

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

Y-BOCS · YALE-BROWN OBSESSIVE COMPULSIVE SCALE

Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown – Patrón de referencia internacional absoluto para la medición de severidad y eficacia terapéutica en el TOC

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS)
Nombre en español	Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown
Sigla oficial	Y-BOCS
Autores originales	Wayne K. Goodman, Lawrence H. Price, Steven A. Rasmussen et al. (1989)
Adaptación hispanohablante	David Mataix-Cols et al. (2002); Banco de Instrumentos CIBERSAM / Bobes et al. (2004)
Año de publicación original	1989 (versión autoinformada validada en 2002; edición clínica de referencia)
Constructo primario	Severidad sintomática cuantitativa del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (independiente del contenido)
Formato de administración	Heteroaplicada mediante entrevista clínica semiestructurada (tras lista de síntomas diana)
Población diana	Adolescentes y adultos (≥ 14 años) con diagnóstico o sospecha clínica de TOC
Tiempo de aplicación	20 a 30 minutos (10 ítems clínicos nucleares precedidos por el inventario de síntomas)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de libre disposición respetando citación de autoría

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

La **Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown** (Y-BOCS) fue desarrollada por Wayne K. Goodman y su equipo en las universidades de Yale y Brown con el propósito fundamental de crear una medida psicométrica estandarizada y universalmente aceptada de la gravedad del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). La brillantez metodológica de la Y-BOCS estriba en un principio clínico fundacional: la escala evalúa la **severidad funcional** de las obsesiones y compulsiones con total independencia del **contenido temático específico** de las mismas (contaminación, duda, simetría, pensamientos agresivos o religiosos).

Para lograr esto, la administración se divide en dos fases: en primer lugar, se cumplimenta la Lista de Comprobación de Síntomas (**Symptom Checklist** de más de 50 temas) para identificar las obsesiones y compulsiones diana activas del paciente durante la última semana; en segundo lugar, se aplican los 10 ítems clínicos centrales que cuantifican las dimensiones estructurales de la enfermedad: el **tiempo ocupado** diariamente por los síntomas, el grado de **interferencia** en la vida cotidiana, el nivel de **angustia subjetiva o distrés**, el esfuerzo activo de **resistencia** desplegado por el sujeto y el grado efectivo de **control** alcanzado sobre las obsesiones y compulsiones. Ha sido el criterio primario de valoración de eficacia en todos los ensayos clínicos con ISRS y psicocirugía.

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Dimensión Y-BOCS	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Subescala de Obsesiones	5 ítems	0 – 20	Ítem 1 (tiempo ocupado: 0 a >8 h/día); Ítem 2 (interferencia funcional); Ítem 3 (angustia/malestar generado); Ítem 4 (resistencia activa); Ítem 5 (control sobre obsesiones).
2. Subescala de Compulsiones	5 ítems	0 – 20	Ítem 6 (tiempo invertido en rituales); Ítem 7 (interferencia conductual); Ítem 8 (ansiedad si se frena el ritual); Ítem 9 (resistencia a ritualizar); Ítem 10 (control sobre la compulsión).
Ítems de Insight e Investigación	Ítems 11 a 16	0 – 4 c/u	Ítem 11 (insight/conciencia sobre la irracionalidad), Ítem 12 (evitación fóbica), Ítem 13 (indecisión), Ítem 14 (duda patológica), etc. (No suman al total).
Puntuación Total Y-BOCS	10 ítems	0 – 40	Suma directa de los ítems 1 al 10 (5 obsesiones + 5 compulsiones). Medida de referencia del TOC.

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Consistencia interna total	Alpha de Cronbach = 0.88 – 0.93	Sobresaliente homogeneidad interna en muestras clínicas de TOC en España (Mataix-Cols et al.).
Consistencia de subescalas	Alpha = 0.84 (Obsesiones); Alpha = 0.86 (Compulsiones)	Ambas subescalas muestran una fiabilidad factorial muy equilibrada y robusta.
Fiabilidad interjueces	CCI = 0.92 – 0.98	Concordancia prácticamente perfecta entre psiquiatras y psicólogos entrenados.
Sensibilidad al cambio terapéutico	Effect size d = 1.40	Sensibilidad insuperable para detectar respuesta a ISRS (clomipramina, fluoxetina) y EPR.
Criterio Internacional de Respuesta	Reducción $\geq$ 35% del total	Estándar de oro consenso en la literatura para declarar respuesta clínica positiva.
Criterio de Remisión Clínica	Puntuación total $\leq$ 12 (o $\leq$ 8)	Puntuación post-tratamiento indicativa de normalización funcional y síntomas subclínicos.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Gradación dimensional de 0 a 4 puntos por ítem:**
 - 0 = Ninguno / Sin tiempo / Control total / Resistencia continua.
 - 1 = Leve (menos de 1 hora al día / interferencia mínima / gran control).
 - 2 = Moderado (1 a 3 horas al día / interferencia clara / control intermedio).
 - 3 = Grave (3 a 8 horas al día / interferencia sustancial / control escaso).
 - 4 = Extremo (más de 8 horas al día / parálisis funcional completa / nulo control).
- **Subescala de Obsesiones:** Suma de los ítems 1 al 5 (rango: 0 a 20 puntos).
- **Subescala de Compulsiones:** Suma de los ítems 6 al 10 (rango: 0 a 20 puntos).
- **Puntuación Total Y-BOCS:** Suma de ambas subescalas (ítems 1 al 10, rango: 0 a 40 puntos).
- **Nota en TOC puro:** Si el paciente presenta obsesiones puras sin compulsiones manifestadas, se interpreta la subescala de obsesiones sobre 20.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

Puntuación Total	Estratificación de Gravedad	Significación Psicopatológica y Repercusión Funcional
0 – 7 puntos	Subclínico / Remisión	Síntomas obsesivos mínimos sin interferencia significativa. Criterio de remisión completa.
8 – 15 puntos	TOC Leve	Interferencia leve en actividades cotidianas (< 1-2 horas/día). Malestar controlable. Indicación de TCC.
16 – 23 puntos	TOC Moderado	Umbral clínico estándar. Rango habitual al diagnóstico inicial. Interferencia marcada (2-4 h/día). Indicación de ISRS + EPR.
24 – 31 puntos	TOC Grave	Compromiso funcional severo (4-8 h/día ritualizando). Grave sufrimiento psíquico e invalidez laboral/familiar.
32 – 40 puntos	TOC Muy Grave / Extremo	Invalidez absoluta (> 8 h/día). Confinamiento por rituales. Considerar ingreso en unidad especializada o neuromodulación.

CRITERIOS DE EFICACIA CONSENSO INTERNACIONAL (GOODMAN ET AL., 1989): 1) **Respuesta Terapéutica:** Reducción $\geq$ 35% de la puntuación basal de la Y-BOCS con CGI-Mejoría de 1 o 2. 2) **Remisión Completa:** Puntuación total final $\leq$ 8 puntos (o $\leq$ 12 con excelente funcionamiento).

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Delimitación de síntomas diana (Symptom Checklist):

- Identificar con el paciente las obsesiones primarias (ej. contaminación con fluidos corporales) y los rituales compulsivos motores o encubiertos (lavados repetitivos, conteos).

Paso 2: Evaluación basal cuantitativa (Ítems 1 al 10):

- Registrar la puntuación total antes de iniciar el tratamiento (habitualmente entre 20 y 30 puntos en consultas especializadas).

Paso 3: Plan terapéutico estructurado según severidad:

- Y-BOCS 8 – 15 (TOC Leve):** Terapia Psicológica de Exposición con Prevención de Respuesta (EPR) como tratamiento de primera línea de elección.
- Y-BOCS 16 – 23 (TOC Moderado):** Abordaje combinado de primera línea: EPR intensiva asociada a ISRS a dosis elevadas (Fluoxetina 60-80 mg, Sertralina 200 mg, Paroxetina 40-60 mg o Escitalopram 20-30 mg/día).
- Y-BOCS 24 – 31 (TOC Grave):** ISRS a dosis máximas + EPR; si tras 12 semanas no hay respuesta, rotar a Clomipramina (150-250 mg/día) o potenciar con antipsicótico atípico (Aripiprazol 5-10 mg o Risperidona 1-2 mg).
- Y-BOCS ≥ 32 Refractario:** Valorar estimulación magnética transcraneal profunda (dTMS) o estimulación cerebral profunda (DBS).

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Varón de 28 años, farmacéutico, consulta por rituales invalidantes de lavado de manos con lejía diluida y duchas de más de 2 horas tras rozar picaportes o dinero, con dermatitis grave en extremidades.

Puntuaciones en la Escala Y-BOCS:

- Puntuación Total Basal: 30 / 40 (TOC Grave).**
- Subescala de Obsesiones: 14 / 20 (tiempo > 5 horas diarias pensando en bacterias; interferencia grave; angustia extrema; nulo control).
- Subescala de Compulsiones: 16 / 20 (Ítem 6 = 4 más de 5 horas diarias lavándose; Ítem 8 = 4 pánico si le interrumpen; Ítem 10 = 4 incapaz de detener el lavado).
- Ítem 11 (Insight): Puntuación = 1 (reconoce con claridad que su miedo a enfermar es irracional).

Tratamiento y Evolución Monitorizada: El insight preservado (ítem 11 = 1) favoreció una excelente respuesta a la psicoterapia. Se instauró Sertralina titulada progresivamente hasta 200 mg/día junto a un protocolo ambulatorio de Exposición con Prevención de Respuesta (EPR) de 20 sesiones. A las 12 semanas, la Y-BOCS total descendió a 18 puntos (reducción del 40%, criterio de respuesta positiva cumplido). A los 6 meses de seguimiento continuado, la Y-BOCS alcanzó 9 puntos (TOC leve/remisión), con normalización de la piel de las manos y reducción del tiempo de ducha a 15 minutos.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE SEGURIDAD Y COMPLICACIONES:

- Lesiones físicas por rituales:** La dermatitis cáustica por desinfectantes o las autoagresiones en rituales exigen intervención dermatológica médica urgente.
- Riesgo autolítico por agotamiento:** Pacientes con Y-BOCS ≥ 32 sufren un dolor moral aplastante que puede derivar en tentativas suicidas de escape.
- Compulsiones encubiertas:** Detectar rituales mentales (rezar, contar, repetir frases) que el paciente oculta y que anulan la eficacia de la EPR.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- TOC con Insight Pobre vs. Psicosis:** Si el Ítem 11 puntúa 4 (ausencia de insight / convicción delirante), asegurar que las ideas se limitan a los temas obsesivos antes de catalogarlo como esquizofrenia.
- Trastorno Dismórfico Corporal:** La preocupación se restringe a un defecto físico percibido, evaluado con la escala específica BDD-YBOCS.
- Tics y Síndrome de Tourette:** Los tics son precedidos por impulsos premonitorios sensoriales corporales, no por obsesiones cognitivas con angustia.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

- Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., ... & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development, use, and reliability. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1006–1011. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1989.01810110048007>
- Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Delgado, P., Heninger, G. R., & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: II. Validity. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1012–1016. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1989.01810110054008>
- Mataix-Cols, D., Marks, I. M., Greist, J. H., Kobak, K. A., & Baer, L. (2002). Self-rated version of the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. *British Journal of Psychiatry*, 181(2), 162–163.
- Bobes García, J., G-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Medica / Psiquiatría Editores.